

PROTOCOLO DE MANEJO DE FIBRILACIÓN AURICULAR Y FLUTTER AURICULAR EN UNIDAD DE OBSERVACIÓN MEDIA ESTANCIA (UOME)

Servicio de Urgencias – Hospital Universitario San Agustín (HUSA) – Avilés

(Versión adaptada a práctica clínica de Observación, recomendaciones ESC 2024 y consenso SEMES)

1. OBJETIVO

Manejo protocolizado de pacientes con fibrilación auricular (FA) o flutter auricular hemodinámicamente estables que precisen observación clínica, control de frecuencia ventricular, optimización terapéutica y valoración de alta precoz segura.

Objetivos:

- Control sintomático.
- Control de frecuencia ventricular.
- Identificación y corrección de factores precipitantes.
- Evaluación de la anticoagulación.
- Estratificación del riesgo.
- Alta precoz segura evitando ingresos innecesarios.

2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Pacientes con:

- FA o flutter auricular conocidos o de nuevo diagnóstico.
- Estabilidad hemodinámica.
- Respuesta ventricular rápida susceptible de tratamiento farmacológico.
- Necesidad de monitorización tras intervención terapéutica.

- Ausencia de indicación de cardioversión urgente.
- Candidato a manejo en Unidad de Observación.

3.CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Derivación a área crítica o ingreso:

- Shock.
- PAS <90 mmHg persistente.
- Dolor torácico isquémico.
- Síndrome coronario agudo.
- Edema agudo de pulmón.
- Insuficiencia cardíaca aguda.
- Síncope arrítmico.
- Necesidad de cardioversión eléctrica urgente.
- Síndrome de preexcitación.
- Arritmias complejas asociadas.
- Sepsis grave.

5. VALORACIÓN INICIAL

Historia clínica

- Tiempo de evolución.
- Síntomas.
- Episodios previos.
- Tratamiento habitual.
- Anticoagulación.
- Factores precipitantes.

Exploración

- FC.
- TA.
- Saturación O₂.
- Temperatura.
- Signos de insuficiencia cardíaca.

ECG

- ECG de 12 derivaciones al ingreso.
- ECG de control según evolución.

Analítica

- Hemograma.
- Bioquímica.
- Función renal.
- Iones.
- Troponina si sospecha clínica.
- NT-proBNP si sospecha de IC.
- Coagulación si anticoagulado.
- TSH según sospecha clínica.

Estratificación

Riesgo tromboembólico

CHA₂DS₂-VA:

Puntuación

- Insuficiencia cardíaca: 1
- Hipertensión: 1
- Edad 65–74 años: 1
- Edad ≥75 años: 2
- Diabetes: 1
- Ictus/AIT/embolismo previo: 2
- Enfermedad vascular: 1

Interpretación (ESC 2024):

- $CHA_2DS_2-VA = 0$: no anticoagulación.
- $CHA_2DS_2-VA = 1$: considerar anticoagulación.
- $CHA_2DS_2-VA \geq 2$: anticoagulación recomendada.

Riesgo hemorrágico

HAS-BLED.

Variable	Puntos
HTA	1
Alteración renal/hepática	1-2
Ictus previo	1
Sangrado previo	1
INR lábil	1
Edad >65	1
Fármacos/alcohol	1-2

0 a 1 punto (Riesgo Bajo)

2 puntos (Riesgo moderado)

> o = 3 puntos (Riesgo alto)

Un HAS-BLED elevado:

- ✗ No contraindica anticoagulación.
- ✓ Obliga a corregir factores modificables y seguimiento estrecho.

6. FACTORES PRECIPITANTES

Investigar y corregir:

- Infección.
- Deshidratación.
- Hipovolemia.
- Anemia.
- Dolor.
- Hipoxemia.
- Hipertiroidismo.
- Alcohol.
- Incumplimiento terapéutico.
- Hipopotasemia.
- Hipomagnesemia.

Objetivos analíticos

Potasio ≥ 4 mEq/L.

Magnesio ≥ 2 mg/dL.

7. CONTROL DE FRECUENCIA

Objetivo terapéutico

Control laxo

- FC 80-110 lpm en reposo.

Si persisten síntomas

- Objetivo más estricto:
- FC 80-90 lpm en reposo.

FEVI conservada (>40%)

Primera línea

- Bisoprolol
- Metoprolol (no disponible en urgencias)
- Atenolol
- Diltiazem.
- Verapamilo.

FEVI reducida

Opciones

- Betabloqueantes.
- Digoxina.

Evitar:

- Verapamilo.
- Diltiazem.

ESC mantiene como tratamiento inicial:

- Betabloqueantes.
- Digoxina.
- Calcioantagonistas no dihidropiridínicos si FEVI >40%.

Tratamiento de primera línea

Bisoprolol VO

Fármaco de elección en nuestro ámbito

Sin tratamiento previo

- Bisoprolol 2,5-5 mg VO.

En tratamiento habitual

- Administrar dosis habitual si omitida.
- Considerar suplemento de 2,5-5 mg VO.

Reevaluación

A las 2-4 horas:

- FC.
- TA.
- Síntomas.
- ECG si procede.

Escalada

Si FC >110 lpm y buena tolerancia:

- Nueva dosis de bisoprolol 2,5-5 mg VO.

Dosis máxima habitual

- 10 mg/día.

Alternativa

Atenolol VO

- 25-50 mg VO.
- Reevaluación clínica a las 2-4 horas.

Dosis máxima:

- 100 mg/día.

Si no se consigue control con monoterapia

Según ESC 2024:

Asociación recomendada

Betabloqueante + digoxina.

Evitar

- Betabloqueante + verapamilo.
- Betabloqueante + diltiazem.

Por riesgo de bradicardia y bloqueo AV.

Insuficiencia cardiaca o contraindicación para betabloqueantes

Digoxina IV

Dosis de carga:

- 0,5 mg IV.

Posteriormente:

- 0,25 mg IV cada 6 horas.

Dosis máxima acumulada:

- 1,5 mg/24 horas.

Ajustar en insuficiencia renal.

Una vez estable introducir betabloqueantes

Persistencia de mal control

Amiodarona IV

Valorar en:

- IC con FE reducida.
- Intolerancia a betabloqueantes.
- Mal control persistente.

Dosis:

- 300 mg IV en 30-60 minutos.

Posteriormente:

- Perfusión continua según evolución clínica.

No utilizar dronedarona para control agudo de frecuencia.

8. FLUTTER AURICULAR

El flutter auricular suele responder peor al control farmacológico.

Valorar precozmente:

- Cardioversión eléctrica.
- Interconsulta con Cardiología.
- Ablación programada.

Especialmente si:

- FC persistente >120 lpm.
- Síntomas relevantes.
- Fracaso de control farmacológico.

9. CONTROL DEL RITMO

Casos muy individualizados sería para ámbito de URGENCIAS no contemplado inicialmente para la UOME

Valorar estrategia de control del ritmo en:

- Primer episodio.
- FA de nuevo diagnóstico.
- FA <48 horas.
- Pacientes jóvenes sintomáticos.
- Flutter típico.
- Recurrencias frecuentes

Cardioversión farmacológica

Sin cardiopatía estructural

- Flecaínida.
- Propafenona.

Con cardiopatía estructural

- Amiodarona.

10. ANTICOAGULACIÓN

Pacientes anticoagulados

- Confirmar adherencia.
- Revisar dosis.
- Ajustar según función renal.

Pacientes no anticoagulados

Valorar inicio según:

- CHA₂DS₂-VA
- HAS-BLED.
- Estrategia de control del ritmo.

Fármacos preferidos

ACOD:

- Apixabán.
- Rivaroxabán.
- Edoxabán.
- Dabigatrán.

Preferidos frente a AVK excepto:

- Prótesis mecánica.
- Estenosis mitral moderada-severa.

NOTA: Tras CVE/CVF : Cuatro semanas de ACOD en TODOS los casos aunque CHA2DSVA 0 . SOLO se podría NO dar si duración del episodio menos de 24 h y CHA2SVA 0

11. MONITORIZACIÓN EN OBSERVACIÓN

- Telemetría continua.
- FC y TA cada 2-4 horas.
- Registro clínico seriado.
- Vigilancia de:
 - Hipotensión.
 - Bradicardia.
 - Insuficiencia cardiaca.
 - Recurrencia arrítmica.
 - Efectos adversos farmacológicos.

Tiempo habitual:

- 6-24 horas.

12. CRITERIOS DE ALTA

Todos los siguientes:

- Estabilidad hemodinámica.
- FC $\leq$ 110 lpm.
- Mejoría clínica.
- Ausencia de insuficiencia cardiaca.
- Ausencia de isquemia.
- Tolerancia oral.
- Tratamiento optimizado.
- Anticoagulación revisada.
- Seguimiento garantizado.

Seguimiento

- Médico de Atención Primaria.
- Cardiología.
- Consulta de arritmias cuando proceda.

13. CRITERIOS DE INGRESO

- Persistencia de FC >110-120 lpm pese a tratamiento.
- Hipotensión secundaria al tratamiento.
- Insuficiencia cardiaca.
- Sospecha de cardiopatía aguda.
- Necesidad de cardioversión no realizable en Urgencias.
- Complicaciones tromboembólicas.
- Mala evolución clínica durante observación.

BIBLIOGRAFÍA

1. European Society of Cardiology. 2024 ESC Guidelines for the Management of Atrial Fibrillation Developed in Collaboration with EACTS. European Heart Journal. 2024.
2. Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Recomendaciones para el manejo de la fibrilación auricular en los Servicios de Urgencias Hospitalarios.
3. Sociedad Española de Cardiología. Documentos SEC-SEMES de manejo de fibrilación auricular en Urgencias.
4. European Heart Rhythm Association. Practical Guide on Atrial Fibrillation and Oral Anticoagulation. Actualización 2024.

Este formato tiene estructura de protocolo hospitalario y es compatible con inclusión en el Manual de Procedimientos de la Unidad de Observación del HUSA.